Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0720443-82.2025.8.07.0001
Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCIA LUIZA VIEITES BORGES
REQUERIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

SENTENÇA

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido cumulado de indenização por danos morais, movida por **MÁRCIA LUIZA VIEITES BORGES** em desfavor da **GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE,** partes qualificadas nos autos.

Nos termos da emenda de ID 233345093, narra a autora que é segurada de plano de saúde operado pela requerida, tendo sido diagnosticada com doença pulmonar intersticial com progressão de sintomas e alterações fibróticas pulmonares, razão pela qual foi prescrita a utilização do medicamento *nintedanibe*.

Relata que, a despeito da imprescindibilidade do medicamento solicitado, a requerida teria negado o seu fornecimento, ao argumento de que não haveria cobertura contratual, uma vez que, no contexto do quadro diagnóstico em questão, não se fariam preenchidos os critérios necessários para tanto.

Diante da imprescindibilidade do tratamento, requereu a concessão de provimento antecipatório, a fim de que fosse determinado o custeio e fornecimento do medicamento, na forma preconizada pelo médico responsável, medida a ser confirmada em sede exauriente.

Ainda, sustentou ter experimentado abalo moral no contexto dos fatos relatados, cuja compensação requereu, mediante indenização estimada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Instruiu a inicial com os documentos de ID 233256111 a ID 233256134, tendo postulado a gratuidade de justiça, deferida pela decisão de ID 234130620.

Por força da decisão de ID 234130620, restou indeferida a tutela liminar de urgência.

Citada, a requerida ofertou contestação (ID 241582392), instruída com os documentos de ID 241585205 a ID 241585209.

Preliminarmente, impugnou a concessão da gratuidade de justiça à requerente, bem como o valor atribuído à causa, que reputa excessivo.

Quanto ao mérito, descreveu que o medicamento não estaria a demandar cobertura, uma vez que, à luz das diretrizes de cobertura que reputa aplicáveis, não teria indicação de custeio para o tratamento da patologia que acomete a parte autora, de modo que, no contexto terapêutico específico, não estaria abrangido pelo rol de cobertura mínima, instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Sustentou, assim, não ter havido a prática de ato ilícito de sua parte, reclamando, com tais fundamentos, o reconhecimento da improcedência da pretensão autoral.

Réplica em ID 242598955, na qual a parte autora reafirmou a pretensão deduzida.

Tendo sido oportunizada a especificação de provas, a parte autora não pugnou pela produção de acréscimo, tendo a ré postulado a obtenção de informações adicionais junto à ANS ou ao NATJUS, bem como a realização de exame pericial (ID 243408429).

Os autos vieram conclusos.

Eis a breve suma do processado.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, eis que a questão jurídica versada, eminentemente de direito, tem seu aspecto fático suficientemente elucidado pelos elementos informativos coligidos aos autos, sendo despicienda a produção de qualquer suprimento probatório adicional.

A prova complementar, cogitada pela ré, mostra-se, na espécie, manifestamente dispensável.

Diante das normas (legais e contratuais) e dos princípios que, no caso vertente, conferem norte à aferição da alegada ilicitude da conduta da operadora, consistente na negativa de custeio da aplicação do medicamento prescrito à autora, mostra-se irrelevante perquirir, junto à ANS, ao NATJUS ou mediante perícia judicial, em providência claramente dilatória, acerca das

indicações do medicamento ou da existência de disposição normativa a excluir o dever de custeio, aspecto este estritamente de direito e passível de elucidação em disciplina positivada.

Não há controvérsia sobre a existência de cobertura contratual para a doença em questão, versando a querela, em verdade e essência, sobre a legitimidade da conduta, consistente em negar a medicação indicada pelo médico que acompanha a paciente, à luz das formalidades legalmente exigidas e da boa-fé, vetor regente da relação contratual, espelhada em seus valores anexos de cooperação e lealdade.

Indefere-se, portanto, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, a dilação probatória suplementar, postulada pela operadora ré, porque a providência ventilada somente se prestaria a postergar a solução da lide.

Passo ao exame dos questionamentos preliminares.

Insurge-se a requerida, em sede preliminar, contra o valor conferido à causa pela demandante, ao argumento de que se afiguraria excessivo, não correspondendo ao proveito econômico almejado com a demanda.

Contudo, verifica-se que a pretensão autoral estaria voltada a compelir a parte ré a cumprir obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear o tratamento prescrito à autora, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

Nesse contexto, revela-se razoável que o valor atribuído à causa seja alcançado por estimativa, tendo por base, em tese, o custo do tratamento almejado, somado àquele atribuído à indenização por danos morais reclamada, não se restringindo a este, na forma aventada pela requerida.

Nesse sentido, o entendimento sufragado no âmbito desta Corte:

> PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃOCÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. RECUSA DE COBERTURA. ENCERRAMENTO DO PRAZO PREVISTO EM LEI. TRATAMENTO ONCOLÓGICO INICIADO DURANTE A VIGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO RADIOTERÁPICO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGURADA NO PLANO PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
> (...)
> 9. **Se o pedido da autora, consistente em obrigação de fazer**

imposta à ré, ora apelante, não possui conteúdo patrimonial imediato (evento futuro), deve a parte atribuir um valor de forma estimativa, tal como realizado na situação em exame. Se o valor estimado encontra-se compatível com o tratamento requisitado pela autora e com o tempo de duração do mesmo, não há como prosperar a impugnação ao valor da causa apresentada pela ré.

10. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão n.1062876, 20161610078778APC, Relator: CESAR LOYOLA 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: 344/366)

Pontue-se, por relevante, que, conforme se colhe do documento de ID 233256134, não infirmado pela demandada, o custo anual do medicamento alcançaria o importe de R$ 321.069,84 (trezentos e vinte e um mil, sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), restando afastado, assim, o alegado caráter aleatório da valoração da pretensão voltada à cominação de obrigação de fazer.

O valor estimado pela parte autora não se mostra, na espécie, aparentemente divorciado daquilo que seria necessário para suprir as despesas com o tratamento médico (o que sequer veio a ser objetivamente elucidado pela requerida), sobretudo se considerada a sua magnitude, de modo que, somado ao valor da indenização por danos morais vindicada, se mostraria ajustado ao que dispõe o CPC, em seu art. 292, incisos II, V e VI.

No que se refere à impugnação à gratuidade de justiça, tampouco comporta acolhida a preliminar.

Dispõe o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que deve ser presumida como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos, apresentada por pessoa natural, estatuindo ainda, o mesmo artigo, em seu § 2º, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Para comprovar a alegada hipossuficiência (que não se confunde com situação de miserabilidade), acostou a parte autora os documentos de ID 233256123 (demonstrativos de proventos), que, de forma suficiente, justificaram a concessão da gratuidade de justiça.

Ressai, com isso, que, a despeito de não se cuidar de presunção absoluta, a reversão da decisão que deferiu a gratuidade estaria a exigir, por sua vez, prova cabal e bastante da falsidade da declaração firmada e da

documentação juntada com o propósito de subsidiar a pretensão inicialmente acolhida para deferir a justiça gratuita, ou mesmo alteração substancial da condição econômica da parte.

Na hipótese, a despeito da impugnação trazida em sede de contestação, inexiste prova documental capaz de arrostar a conclusão inicialmente alcançada, no sentido de que estaria a parte autora, à luz da CRFB (art. 5º, LXXIV) e da Lei 1.060/50, impossibilitada de arcar com as despesas processuais (custas e honorários), sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Nesse sentido, caberia à parte impugnante deduzir elementos concretos e materialmente auferíveis, capazes de demonstrar a alegada disponibilidade de recursos omitidos, não sendo suficiente a simples construção de conjecturas.

Ademais, vale destacar, que conforme expressa previsão contida no art. 99, § 4°, do CPC, o fato de estar a parte assistida por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça.

Inviável, portanto, o acolhimento da impugnação, à míngua de elemento probatório suficiente a demonstrar, com inequívoca clareza, a falsidade dos elementos coligidos e da própria afirmação feita, em juízo, pela parte hipossuficiente, a fundamentar, na forma pretendida, a imediata revogação da gratuidade de justiça.

Rejeito, **portanto, às inteiras, os questionamentos preliminarmente arguidos pela parte requerida**.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais pendentes de apreciação, avanço ao exame meritório.

No caso, cumpre destacar, de início, que o verbete sumular de n° 608, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, assentou não ser aplicável o microssistema consumerista às relações contratuais havidas com as entidades de autogestão, modalidade de administração especificamente utilizada pela ré.

Fixada tal premissa, verifico que se mostra incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, diante da documentação trazida aos autos e da ausência de impugnação relacionada a tal aspecto.

A controvérsia transita, portanto, por sindicar a legitimidade da negativa do custeio, fundada na alegação de que o tratamento reclamado, prescrito pelo médico que assiste a paciente estaria à margem da cobertura legal e contratual, por não dispor a medicação de indicação de cobertura no específico contexto diagnóstico e terapêutico.

Com a juntada do relatório médico (ID 233256124), firmado pelo médico responsável, constata-se que teria a paciente sido diagnosticada com quadro de *DOENÇA PULMONAR FIBROSANTE*, *COM FENÓTIPO FIBROSANTE PROGRESSIVO.*

Para tentar conter a evolução da moléstia, teria sido preconizado o tratamento com a medicação NINTEDANIBE, medida determinada pela realização de tratamento antecedente, sem êxito na contenção da doença.

Em seu arrazoado resistivo, amparou a requerida a negativa de cobertura na existência de previsão legal e contratual de exclusão, já que o fármaco não teria previsão no rol de procedimentos da agência reguladora responsável para o quadro clínico em questão.

Nesse ponto, sobreleva destacar que inexiste qualquer razoabilidade em se negar o custeio de uma medicação, prescrita pelo especialista que acompanha o quadro de saúde do paciente, ao pálido argumento de ausência de adequação do fármaco ao tratamento do quadro clínico.

Como é cediço, cabe ao especialista - e não à operadora de plano de saúde - definir o tratamento mais adequado ao paciente, notadamente diante da constatação de que a doença teria cobertura e o medicamento prescrito estaria formalmente registrado na Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Nesse mesmo sentido, o entendimento já manifestado, em mais de uma oportunidade, pelo Superior Tribunal de Justiça:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL**.** NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF LABEL -. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte. 2. **O acórdão recorrido está em sintonia com <u>o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, segunda o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate fármaco off label, ou utilizado em caráter</u>**

experimental. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1567178/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

Ademais, o fato de não estar o tratamento expressamente nominado na listagem de procedimentos de saúde da ANS não seria causa bastante, de *per se*, a amparar a negativa manifestada, tendo em vista a natureza não exaustiva do mencionado rol, preconizada pela Lei n. 9.656/98, em seu art. 10, § 13º, incluído pela Lei n. 14.454/2022, que assim vem a dispor:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)*
>
> ***I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**; ou (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído pela Lei nº 14.454, de 2022)*

Na hipótese, para além da solicitação médica (ID 233256124), que sinaliza com a adequação do tratamento ao caso diagnosticado, verifica-se que tal constatação **seria corroborada por nota técnica lavrada por Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, acostada em instrução da petição inicial (ID 233256134)**, que veicula exposição em que a indicação do procedimento ao caso dO paciente vem a ser suficientemente fundamentada, em parecer favorável.

Cabe pontuar que tal parecer, que versa sobre hipótese diagnóstica análoga àquela verificada no caso em tela (doença pulmonar fibrosante – ID 233256134/pág. 2), veio a consignar que *o uso do nintedanibe está indicado naqueles casos com doença progressiva (fenótipo progressivo), ou seja, naqueles casos em que há perda de função pulmonar com o tempo* (ID 233256134 – pág. 10).

Elucida o estudo especializado, ainda, que as evidências científicas apontam que *o nintedanibe pode reduzir o ritmo de deterioração da função pulmonar em pacientes com doenças fibróticas dos pulmões com fenótipo progressivo, embora não tenha potencial de reverter as lesões já instaladas* (ID 233256134 – pág. 11), tendo concluído positivamente pela existência de evidências científicas a amparar manifestação favorável à administração do medicamento ao quadro clínico.

Verifica-se, portanto, que resta evidenciada a comprovação da eficácia do tratamento, a determinar, por força do disposto no art. 10, § 13º, I, da Lei nº 9.656/98, a cobertura pelo plano de saúde.

Desse modo, tem-se que a conduta da parte ré, consistente em negar a cobertura para medicamento necessário ao tratamento vital à saúde da autora, destoa do arcabouço normativo e principiológico de proteção ao usuário dos planos de saúde, por tolher o direito da segurada de ter acesso, em sua inteireza e com desejável eficácia, à terapia indicada por médico especialista.

Impera, em tais situações, que a parte seja protegida em suas necessidades médicas, ainda mais quando estão em cotejo bens maiores e prevalentes, caracterizados pela vida e a saúde, dando-se, pois, em eventual ponderação, primazia aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Nesse quadro, faz jus a autora à cobertura das despesas decorrentes da realização do procedimento prescrito, uma vez atestada a sua imprescindibilidade por médico responsável e habilitado.

Assim pontuada a violação, decorrente da ilicitude da negativa de custeio do tratamento preconizado, examino os danos alegadamente suportados e atrelados à conduta da prestadora.

Pleiteou a parte autora, cumulativamente, a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da aflição psicológica e da situação de angústia, vivenciadas por força da injustificada negativa de fornecimento do fármaco, havido como imprescindível para frear a evolução de seu quadro clínico.

É incontestável o abalo experimentado pela requerente, derivado da situação de vulnerabilidade a que esteve submetido, o que se vislumbra do cenário de incerteza quanto à realização de tratamento de emergência, prescrito para tratamento de doença respiratória progressiva, que não se verificaria - ou mesmo teria reduzida sua repercussão – caso tivesse a ré atuado de forma adequada na prestação de seus serviços, que se mostraram gravosamente deficitários.

A atitude da ré, para além de atingir as legítimas expectativas da contratante, colocada em situação de evidente vulnerabilidade, mostrou-se relevante e com suficiente aptidão para atingi-la, de forma gravosa, em suas esferas de tutela da integridade física e psicológica, acarretando abalo imaterial relevante e passível de compensação.

A conduta omissiva ilícita, caracterizadora de falha grave na prestação do serviço contratado, a afrontar, com relevância, a dignidade do usuário do plano de saúde, além do nexo de causalidade, a atrelar tais requisitos, se acham, nesse contexto, incontroversos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema atinente à indenização do abalo decorrente da negativa de atendimento por plano de saúde, assentou, em brilhante voto da lavra da Ministra NANCY ANDRIGHI, que, *"conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada."* (REsp 986947/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 11/03/2008, DJe 26/03/2008, RT vol. 873 p. 175).

A conduta da ré, na espécie, ensejou gravame que desborda, à evidência, os limites do mero dissabor, vindo a atingir direitos afetos à personalidade, notadamente no que se refere à tutela da integridade física e psicológica.

Sendo nítida a prática do ato ilícito, perpetrado mediante conduta omissiva e injustificada, configurado o dano (*in re ipsa*) e presente o nexo de causalidade, impõe-se o dever de compensar, à luz do Código Civil (artigos 186 e 927, *caput*).

Em relação ao valor devido a título de compensação, impende prestigiar, à luz do caso concreto, os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, condensados e permeados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

Com isso, deve a indenização ser arbitrada de modo a cumprir seu dúplice desiderato, consistente na necessidade de se compensar – consideradas a extensão e a gravidade do dano - o gravame imaterial suportado, aliada à função pedagógica da condenação, que visa a sancionar e desestimular, por parte da ré, a recidiva, exortando-a a agir com boa fé e presteza em hipóteses assemelhadas e subsequentes.

Forte em tais balizas, e, consideradas as condições econômicas da parte ofensora, o grau de responsabilidade, a gravidade e a extensão dos danos suportados, informado ainda pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa, tenho como justa e suficiente a fixação da compensação, pelos danos extrapatrimoniais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao cabo do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos, para:

a) Condenar a operadora requerida em obrigação de fazer, consistente em autorizar a cobertura e promover o custeio do tratamento com o medicamento necessário à paciente (*Nintedanibe)*, nos moldes da manifestação firmada pelo médico responsável (ID 233256124);

b) Condenar a requerida ao pagamento, a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais suportados pela parte autora, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros mensais, pela taxa legal (Código Civil, art. 406), desde a citação.

Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor de R$ 326.069,84 (trezentos e vinte e seis mil, sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde ao proveito econômico obtido com a demanda, à luz do valor atribuído à causa (ID 233345093 – pág. 19) e do conteúdo da presente sentença, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Sentença datada e registrada eletronicamente.

Publique-se e intimem-se.

Transitada em julgado, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se.

Comunique-se a prolação da presente sentença ao eminente Desembargador Relator do agravo de instrumento de nº 0717983-28.2025.8.07.0000.

***documento datado e assinado eletronicamente pelo(a) Magistrado(a).**

Assinado eletronicamente por: ACACIA REGINA SOARES DE SA
23/07/2025 16:49:44
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25072316494428800002214

IMPRIMIR GERAR PDF